

KAPSAMLI LOOKSMAXING, FARMAKOLOJİ VE PROTOKOL REHBERİ

Bu doküman; ders transkriptlerindeki tüm farmakolojik dozajların, yüz anatomisi çalışmalarının ve beslenme protokollerinin eksiksiz derlemesidir.

1. KAN BASINCI YÖNETİMİ & FARMAKOLOJİ

Hipertansiyon Mekanizması: RAAS ve Reseptör Dengesi

- AT1 Reseptörü: Vazokonstriksiyon, fibrozis ve kan basıncı artışının ana sorumlusu.
- AT2 Reseptörü: Vazodilatasyon, doku onarımı ve AT1 etkilerini dengeleme işlevi görür.

Ekzojen androjen kullanımı dengeyi AT1 lehine bozar.

Bileşikler ve Dozajlar

- Telmisartan (ARB & PPAR- γ Agonisti): AT1'i bloke eder, insülin duyarlılığını artırır, anti-aldosteron etkisiyle su tutulumunu keser. Dozaj: 150 mg testosteron başına ~50 mg (300 mg test için ~100 mg; hedef: ~120/75 mmHg).
- Tadalafil / Cialis (PDE5 İnhibitörü): Damarları gevşetir, vazodilatasyon ve pompa sağlar. Yarılanma ömrü ~72 saat. Dozaj: Günlük 5-10 mg veya iki günde bir.
- Propranolol (Beta Bloker): Adrenalin ve kalp hızını düşürür, anksiyeteyi keser. Antrenmandan önce alınmaz; gece yatmadan önce tercih edilir. Dozaj: Günlük 40-60 mg veya tansiyon yükseldiğinde gerektiğinde (PRN).

2. HİPERTROFİ VE YAĞ YAKIMI (BESLENME PROTOKOLÜ)

- Motor Unit Recruitment (MUR) & Karbonhidrat: Merkezi sinir sisteminin yeni lifleri devreye sokması glikojene bağlıdır. Antrenman öncesi tek seferde ~300g karb (~1200 kcal) tüketimi hedeflenir. Günün geri kalanında yüksek karba ihtiyaç yoktur.
- Myofibrillar Protein Synthesis (MPS) & Protein: Vücut ağırlığının libresi (lbs) başına 0.7 - 1.0 g protein yeterlidir.
- Diyet Yağı: Yağ tüketimindeki dalgalanmanın doğal testosterona etkisi (~100 ng/dL) kas inşası için önemsizdir. Yağ alımı 50g altına, agresif dönemde 10g altına indirilerek kalori açığında recomp yapılır.

3. TESTOSTERON VE YAN ETKİ MİTİGASYONU

- Jinekomasti (E2): Aromataz testosteronu östrojene çevirir. Hedef E2: 40-60 pg/mL. Çözüm: Günlük 5-10 mg Aromasin (Exemestane).
- Saç Dökülmesi (DHT): Dökülmenin %95'i DHT kaynaklıdır; çözüm Dutasteride. Kalan %5 saf testosteron için topikal anti-androjen RU58841 (günde 1 kez duş sonrası saç derisine 1 mL / 50 mg).
- Akne: Hormon dalgalanmalarını kesmek için dozu bölerek her gün enjeksiyon yapmak ve Dutasteride ile DHT/sebumu baskılamak.
- Roid Bloat / Yüz Şişkinliği: E2'nin mineralokortikoid reseptörünü (MR) uyarmasını engellemek için günde ~50 mg Eplerenon.

4. İNHİBİSYON DÜŞÜRME (SOSYAL BECERİ VE DÖNGÜ)

- Alkol: GABA-A agonisti ve glutamat baskılayıcıdır; kognitif/motor becerileri bozar ve toksiktir.
- Benzodiazepinler: Bağımlılık ve yoksunluk riski nedeniyle önerilmez.
- Pregabalin: Nörotransmitter salınımını azaltır, kafayı alkol kadar bulandırmaz; tolerans hızlı gelişir (haftada 1'den fazla kullanılmaz).
- Baklofen: GABA-B agonistidir; dolaylı dopamin düşüşüyle sosyal ortamlarda heyecansız/donuk bırakabilir.

Not: Kalıcı ve sağlıklı tek çözüm Maruz Kalma Terapisidir (Exposure Therapy).

5. MELANOTAN 2 (MT2) BRONZLAŞMA PROTOKOLÜ

- Dozaj: 10 mg flakona 2 mL bakteriyostatik su konur. Dozaj: 350 mcg (subkutan), seans öncesi 30 dk önce.
- Güneş Koruması: Mutlaka SPF ile girilir (UVB engellenir, bronzlaştıran UVA geçer). Seans: Maksimum 30 dakika.

- Kış Koruması: Haftada iki kez 100 mcg.

Not: Roaccutane veya topikal Tretinoin kullananlar fotosensitivite nedeniyle MT2 ve UV'den uzak durmalıdır; cildi kalıcı yaşlandırır.

6. DOĞAL IGF-1 & TESTOSTERON MAKSİMİZASYONU

- Doğal IGF-1: Kolostrum, kemik suyu, kırmızı et, yumurta, tam yağlı süt ürünleri. Ağır bileşik egzersizler (Squat, Deadlift, Bench, Barfiks) %75-85 1RM ile 6-10 tekrar. Sprint HIIT (30 sn sprint / 60 sn dinlenme x 5). Antrenman sonrası soğuk duş/buz banyosu; haftada 2-3 kez sauna.
- Doğal Testosteron: Sağlıklı doymuş/tekli doymamış yağlar, çiğ bal (boron), dana karaciğeri, istiridye, turpgiller. Plastiklerden (BPA, fitalat), parabenlerden ve fitoöstrojenlerden kaçınmak. Bol pamuklu iç çamaşırı, topraklanma (grounding), 15-30 dk güneş ışığı.

7. ÇENE VE ALT YÜZ ESTETİĞİ

- Anatomi: Ramus dikey uzunluğu gonial açığı belirler; dışa dönük (extroverted) gonion maskülendir. Hyoid kemiğinin yüksekliği çene altı sarkmasını önler.
- MPR (Mental Protuberance Resistance): Çene ucuna başparmaklarla yukarı direnç verirken ağzı açıp kapatma. Suprahyoid kaslarını gergin (tort) yaparak hyoid kemiğini yukarı asar. Günde 5-8 set x 20 tekrar (tıklama sesi/TMJ varsa anında durdurulur).
- Hatalar: Çiğneme kauçukları ve havlu asılma diş ve ekleme zarar verir; direnç havuç, biftek gibi sert doğal gıdalardan alınmalıdır. Asimetri varsa zayıf tarafla %70 oranında çiğnenmelidir.

8. GÖZ, KAŞ VE YÜZ KAS KONTROLÜ

- Orbicularis Oculi (Hunter Eyes): Alında kırışıklık yaratmadan gün boyu hafif kısma (squinting). Göz kenarlarını parmakla yukarı çekip dirence karşı gözleri kapatıp açma. Auricularis posterior (kulak arkası kası) ile dış kantusu yukarı taşıma.
- Kaş Kontrolü: Frontalis kasını tamamen gevşetip temporalis/occipitalis kaslarıyla kafa derisini arkaya sıkıp kaş dışını yukarı çekme (günde 10-12 tekrar, 5 sn tutuş).

9. İSKELET DÜZELTMELERİ, BOY VE POSTÜR

- Damak Genişleticiler: Dar damağa bağlı solunum ve çapraz kapanış sorunları için ortodontik cihazlardır; yetişkinlerde cerrahi/vidalı yöntemler gerekir.
- Sütür Teorisi: 20-25 yaştan sonra kafatası dikişleri kaynaşır; sert mekanik kuvvetlerle kemik itilemez.
- Omurga Dekompresyonu (Anlık 1-2 cm Boy): Barfiks barında asılı kalma (günde 3-5 kez 20-30 sn), Cat-Cow esnemesi ve foam roller.

10. DERMATOLOJİ VE CİLT BAKIMI

- Lenfatik Drenaj: Boyun lenfleri kulaktan köprücük kemiğine süpürülerek açılır; ardından çeneden kulağa, burundan şakaklara masaj yapılır.
- Göz Altı: Ödem için akşam tuzu kesilir, çift yastıkla yatılır, kafeinli krem kullanılır. Yağ torbaları soğukla geçmez; retinoid veya cerrahi gerekir. Morluklar için C vitamini, niasinamid ve K vitamini.
- Cilt Temizliği: Günde maks 2 kez nazik yıkama. Aktif aknelere kese yapılmaz; salisilik asit (BHA) veya benzoil peroksit kullanılır. Yastık kılıfı ipek/bambu olmalı ve 2-3 günde bir değişmelidir.

11. YÜZ ŞEKLİNE GÖRE SAÇ STİLİ

- Oval: Neredeyse her model uyar; alnı kapatan ağır perçemden kaçınılmalı.
- Yuvarlak: Üstte hacim/yükseklik, yanlar kısa (fade/undercut).
- Kare: Sert açılı yumuşatmak için dokulu crop veya katlı kesimler.
- Dikdörtgen / Uzun: Yanlar sıfırlanmamalı, yanlara hacim verilip üstler aşırı uzatılmamalı.
- Elmas / Kalp: Dar çeneyi dengelemek için favori ve ense arkasında hacim bırakılmalı.

12. RİSKLİ UYGULAMALAR

- Su Atma (Water Cutting): 4 g n sıfır karb + g nde 1-2 galon su, son 24 saat sıfır su. Hiponatremi ve b brek yetmezliđi riski vardır; podyum harici yapılmaz.
- Y z Yogası: Kırışıklıkları artırır, kemik yapısını deđiřtirmez.
- Yan Yatmak: Y z kemiklerine tek taraflı baskı yapıp asimetri yaratır; sırt  st  uyunmalıdır.